

TEMA 5.23 • OFTALMOLOGÍA

oftalmología pediátrica 2

PERFIL EUNACOM 6.02.1.011

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Oftalmología Pediátrica (Parte 1): Ambliopía y Estrabismo

El screening temprano visual en la primera infancia es esencial e irremplazable debido a la temida plasticidad neurológica. Si se diagnostica un defecto precozmente y se corrige, el niño asegura función visual plena, pero cruzada la barrera etaria, los resultados de fallas se vuelven crónicos e irreversibles.

1. Ambliopía ("Ojo Flojo")

Es la manifestación profunda cerebral y reducción secundaria irreversible de la agudeza visual de un ojo que no presenta inicialmente una disfunción anatómica propia severa en la retina, sino que ocurre por **Deprivación del Desarrollo Neurológico Visual Central** en la vía occipital cerebral, secundario netamente a que el ojo afectado durante sus primeros meses y años cruciales no recibió el estímulo luminoso limpio constante para forzar al cerebro base a madurar sus vías nerviosas correspondientes a ese hemisferio.

- ##### Banderas Rojas y Causas Primarias Generadoras:
- **Estrabismo precoz no resuelto (Causa inmensa):** Para que el niño no "vea doble y de forma montada" (diplopía) originada por los ejes traccionados y desviados, su inteligente cerebro base prefiere en defensa apagar, bloquear e inhibir centralmente la señal visual reentrante por parte exclusiva del ojo anómalamente desviado, abandonando permanentemente la conectividad cruzada.
- **Vicios y Refracciones Focales Asimétricas (Anisometropía Severa):** Cuando un ojo tiene una diotría brutalmente mayor perimetral asimétrica (ej. ojo normal 20/20 y cruzado contralateral altísimamente miope).
- **Causas visuales perimetrales oclusivas base:** Cualquier patología limitante innata tipo **Catarata Congénita** o la infrecuente pero presente severa la caída del párpado base total focal unilateral del lactante o una **Ptois Congénita** severa paralítica.
- ##### Manejo Base
- El diagnóstico temprano base (antes y dentro margen del periodo maleable plasticidad crítica menor base perimetral a 7 años general es mandatorio).
- El abordaje basal general más efectivo cruza mediante el temporal "Castigo Punitivo temporal Físico" aislando y privando temporal al **Ojo Fuerte base y sano** por forzada limitación ocluyendolo (Uso Ocular de **Parche Oclisor estricto oftalmológico**) obligando base con severidad a forzar a obligar entrenarse biológicamente base neurológico el de base perezoso pasmado débil "ojo flojo o ambliópico".

2. Estrabismo ("Bizco")

Desviación franca lateral, superior o medial pasiva del tradicional eje normal con el objetivo focal anatómico simétrico del cruce o mirada biótica.

- Formas: Hacia el eje interior medial o nasal limitante general es **Endotropia** (clásico estrabismo infantil convergente). Hacia fuga periférica asimétrica hacia afuera general u orejas se nombra **Exotropia** divergente. (El diagnóstico semiológico no es una asimetría clínica evidente al "ojo desnudo" sino la objetivación médica directa clínica infalible llamada la base prueba del control EUNACOM: **Test de Hirschberg** perimetral).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Test de Hirschberg EUNACOM (Reflejo Corneal Luminoso):

Protocolo infalible ambulatorio. Al iluminar directamente de frente con oftalmoscopio ambos ojos del paciente. Biológicamente es mandatorio por física y normalidad que los nítidos puntos de reflejos de estrellitas blancas de la luz artificial proveniente del foco tienen que "golpear" asimétricamente y brillar simétricos idénticos rebotando perimetralmente en paralelo exacto ubicados geográficamente en el mismísimo centro biótico medio milimétrico de las dos pupilas del menor evaluado. De rebotar y reflejarse y hallarse el brillo del destello más excéntrico natural al centro de la pupila evaluada o hacia fuera es categórico un Estrabismo biológico oculto franco.

Diagnóstico Diferencial de Especial y Trascendental Derivación Estándar Biótica

- **El Estrabismo Madurativo Transitorio Fisiológico Inespecífico:**
- - Es totalmente transitorio e idiopático, normal fluctuante base fisiológica inicial. En los estadios formativos tempranos ocurre por laxitud focal generalizada del bebé. Rango cronológico basal normal es que puede decantar y fluctuar normal perimetral en infantes **Hasta MÁXIMO los 6 MESES crásicos de vida legal neonatal biológica formativa.** (Siempre siendo de la variedad "Intermitente Falsa Fluctuante en cruces o al fatiga del crio). Superados inconfundiblemente exactos los 6 meses crónicos estables cualquier extraña mirada focal es y constituye patológico fijo anormal general.
- **Pseudostrabismo Ocular de Base Pediátrica Fisiológico General y Etnico Base:**
- - Curda a raíz a la estructura cutánea pliegal nasal muy aplanada y amplía cruzada gruesa oriental o general de niños y base pliegues prominentes cantales gruesos epicánticos (**Epicanto**). Cierra falsamente biológicamente gran parte visual nasal ocultando base falsa perimetral esclera pareciendo que tuviera cruzado los ojos internamente el bebé y que el test lumínico general o de Prueba básica del **Clásico Base de Hirschberg infalible se presenta perimetral Normal cruzado y el destello biótico centrado.**

EUNACOM CRITERIOS

Criterios Absolutos Médicos de Urgencia Derivatoria

oftalmológica: Derivará inmediatamente y perentoriamente por riesgo ambliópico vital toda manifestación estrabística infantil a oftalmología en caso natural per se de catalogarlo por base cruzada de variedad **FIJA O INCESANTE constante pura sin fluctuaciones.** Incluso si cursa cruzada siendo neonato precoz lactante, o obligatoria pasivamente derivación general en general pasados y cumplidos bióticamente y el límite superior general y los de los **6 primeros crudos e inflexibles meses biológicos base de edad.**

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un lactante de dos meses llega a control sano. La madre refiere lagrimeo excesivo del ojo derecho desde la primera semana de vida. Al examen el ojo derecho tiene epifora pero sin hiperemia conjuntival. La córnea es clara y de tamaño normal. La presión intraocular es normal. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta inicial?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para oftalmología pediátrica 2. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La obstrucción de la vía lagrimal en lactantes se debe a imperforación de la válvula de Hasner; el diagnóstico es clínico con epífora desde el primer mes y la conducta inicial es observación con masajes hasta el año de vida.
- Si la obstrucción persiste después del año se realiza cateterismo nasolagrimal bajo anestesia; la dacriocistorrinostomía es el último recurso si el cateterismo falla.
- El glaucoma congénito es una urgencia oftalmológica que se presenta con la tríada de bupftalmia o megalocórnea, córnea opaca y epífora; las estrías de Haab son patognomónicas.
- El tratamiento del glaucoma congénito es siempre quirúrgico con goniotomía o trabeculotomía; el tratamiento médico es solo transitorio previo a la cirugía.
- El retinoblastoma es el tumor ocular maligno más frecuente en niños; la leucocoria es el signo más frecuente y la sobrevida supera el noventa y cinco por ciento si se detecta precozmente.
- Un cuarenta por ciento de los retinoblastomas tiene mutación del gen RB1 con herencia autosómica dominante, lo que obliga a tamizaje en familiares.
- El diagnóstico diferencial de leucocoria según la edad es clave: desde el nacimiento sugiere catarata congénita, y leucocoria que aparece después de los primeros meses sugiere retinoblastoma; cualquier leucocoria requiere derivación urgente al oftalmólogo.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA 2)**PREGUNTA 1**

Un lactante de dos meses llega a control sano. La madre refiere lagrimeo excesivo del ojo derecho desde la primera semana de vida. Al examen el ojo derecho tiene epífora pero sin hiperemia conjuntival. La córnea es clara y de tamaño normal. La presión intraocular es normal. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta inicial?

- A)** Glaucoma congénito; derivación urgente al oftalmólogo para cirugía
- B)** Obstrucción de la vía lagrimal; observación con masajes hasta el año de vida
- C)** Conjuntivitis neonatal; antibióticos tópicos inmediatos
- D)** Dacriocistitis aguda; amoxicilina-clavulánico oral inmediato
- E)** Cataratas congénitas; derivar para evaluación del reflejo rojo

PREGUNTA 2

Un lactante de cuatro meses es traído por sus padres porque notan que los ojos están grandes y una de las córneas aparece algo opaca. Al examen hay megalocórnea bilateral, edema corneal derecho y lagrimeo con fotofobia. La tonometría bajo sedación muestra presión intraocular de treinta y dos milímetros de mercurio en el ojo derecho. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento de elección?

- A)** Miopía magna bilateral; corrección óptica con lentes
- B)** Queratitis bacteriana; antibióticos tópicos urgentes
- C)** Glaucoma congénito; tratamiento quirúrgico con goniotomía o trabeculotomía
- D)** Síndrome de Axenfeld-Rieger; observación periódica
- E)** Glaucoma congénito; timolol tópico como tratamiento definitivo

PREGUNTA 3

Los padres de un niño de dieciocho meses notan que en las fotos con flash el ojo izquierdo aparece blanco en vez de con el reflejo rojo habitual. Al examen el reflejo rojo del ojo izquierdo está ausente. No hay antecedentes familiares conocidos de tumor ocular. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta?

- A)** Catarata congénita del ojo izquierdo; programar cirugía electiva
- B)** Retinoblastoma del ojo izquierdo; derivación urgente al oftalmólogo
- C)** Hemorragia vítrea traumática; observar y repetir examen en dos semanas
- D)** Toxocariasis ocular; tratamiento antiparasitario oral
- E)** Reflejo rojo anormal por anisometropía; corrección óptica con lentes

RESUMEN: OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA 2

La segunda clase de oftalmología pediátrica aborda tres entidades de gran importancia clínica y preventiva: la obstrucción de la vía lagrimal, el glaucoma congénito y el retinoblastoma, junto con el diagnóstico diferencial de la leucocoria. La obstrucción de la vía lagrimal es una causa frecuente de epífora en lactantes y se debe habitualmente a imperforación de la válvula de Hasner en el extremo distal del conducto nasolagrimal. El diagnóstico es clínico, con epífora desde el primer mes de vida, y se debe descartar siempre el glaucoma congénito como causa alternativa de lagrimeo. La conducta inicial es expectante con masajes nasales, ya que la mayoría resuelve espontáneamente antes del año de vida. Si persiste después del año, se realiza cateterismo del conducto nasolagrimal bajo anestesia, y si eso falla, dacriocistorrinostomía. El glaucoma congénito es una urgencia oftalmológica pediátrica porque produce pérdida visual irreversible si no se trata a tiempo. Se presenta con la tríada de buphtalmia o megalocórnea, córnea opaca y epífora, más fotofobia y blefarospasmo. Las estrías de Haab son roturas en la membrana de Descemet que son patognomónicas. El tratamiento es quirúrgico con goniotomía o trabeculotomía, nunca solo médico. El retinoblastoma es el tumor ocular maligno más frecuente en la infancia y su diagnóstico precoz cambia radicalmente el pronóstico: si se detecta antes de la diseminación, la sobrevida supera el noventa y cinco por ciento. El signo más frecuente y más importante es la leucocoria, seguida del estrabismo. Un cuarenta por ciento de los casos tiene mutación genética del gen RB1 con herencia autosómica dominante, lo que obliga a tamizaje en hermanos y familiares. El diagnóstico diferencial de leucocoria según la edad de presentación es clave: desde el nacimiento sugiere catarata congénita, y si aparece después de los primeros meses sugiere retinoblastoma. Cualquier leucocoria en un niño es derivación urgente al oftalmólogo.